HELP_Organi_P23 — Groupe E — Lots 242 à 246 — 19 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 23 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

E-064 — Moyenne — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_245_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › fenêtres « neuf centres pour maladies rares (CMR) » et « centres de référence kosek » ; Partie 2 › DX.4 › fenêtre « réseau de proximité avec un centre de référence » [Appel A non déposé (filtre de sécurité) : réinjecter dans le fichier local]

Contexte : Le cours cite la reconnaissance par la kosek (4 centres métaboliques et 7 neuromusculaires en 2021, 25 supplémentaires en 2024) ; base légale fédérale et liste nominative des centres absentes.

Question : Quelle est la liste actuelle (2025–2026) des centres pour maladies rares et des centres de référence reconnus par la kosek (par groupe de maladies, dont hématologie et drépanocytose), quelle est leur base légale ou contractuelle et où en est le Concept national maladies rares (OFSP) et la motion de financement ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :

5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-065 — Moyenne — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_245_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_245_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › fenêtres « Les prévalences suisses mesurées sont rares » et « Une valeur de prévalence suisse n'existe que pour deux entités » ; Partie 1 › DX.1 et DX.2 (prévalence) ; Partie 2 › DX.3 (survie médiane, prévalence 11,1/100 000), DX.4, DX.5 [Appel A non déposé (filtre de sécurité) : réinjecter dans le fichier local]

Contexte : Le cours utilise Orphanet (prévalences européennes) ; prévalences suisses de la myasthénie, de la sclérodermie, de la mucoviscidose, de la drépanocytose et de la maladie de Wilson et survie médiane suisse de la mucoviscidose non trouvées (chiffre allemand 40 ans en 2017).

Question : Quelles prévalences suisses mesurées existent pour la myasthénie, la sclérodermie systémique, la mucoviscidose (registre ECFS Patient Registry, part suisse, survie médiane), la drépanocytose et la maladie de Wilson (registres, études de cohorte, dépistage néonatal suisse) ? Donner le chiffre suisse le plus récent (source, année, URL : OFS, OFSP, registre ou rapport national) ; à défaut, le chiffre européen le plus récent avec sa méthode de mesure.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-066 — Moyenne — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_245_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › tableaux d'interprétation DX.3 (TIR-1, TIR-2) et DX.4 (étude de l'hémoglobine, HbF) ; Bloc 1 › tableaux d'interprétation (anti-RACh, TIR, étude de l'hémoglobine, céruloplasmine, cuivre hépatique, C1-INH, α-Gal A, scintigraphie osseuse, PBG urinaire) [Appel A non déposé (filtre de sécurité) : réinjecter dans le fichier local]

Contexte : Le cours donne les seuils pathologiques (céruloplasmine 0,1–0,2 g/L = 1 point, cuivre hépatique > 250 µg/g, fonction C1-INH < 50 %, scintigraphie grade 2–3, PBG élevé) mais pas les valeurs normales ni la définition des grades.

Question : Quelles valeurs de référence et quels seuils diagnostiques recommandent les sociétés européennes pour l'anticorps anti-RACh, la TIR néonatale, la céruloplasmine et le cuivre urinaire et hépatique (score de Leipzig, EASL-ERN 2025 Wilson), la fonction C1-INH et le C4, l'activité α-Gal A et le lyso-Gb3, le grade de Perugini en scintigraphie osseuse (ESC 2021 cardiomyopathies, 2023) et le PBG urinaire (seuil en multiple de la normale, EPNET) ?

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-068 — Moyenne — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › Partie 1 › DX.2 › 7.4 syndrome inflammatoire (arthrite, atteinte digestive) de la sclérodermie

Contexte : Le cours cite les recommandations EULAR 2023 (huit domaines) sans détails thérapeutiques pour l'arthrite et l'atteinte digestive.

Question : Quels traitements recommandent les recommandations EULAR 2023 sur la sclérodermie systémique pour l'arthrite et l'atteinte digestive (IPP, prokinétiques, antibiotiques en rotation), avec doses et spécialités suisses ? Pour chaque médicament, donner selon l'information professionnelle suisse (AIPS, swissmedicinfo.ch, date de révision) : spécialité ®, titulaire, indication autorisée, dose, voie, rythme, durée et adaptations rénale, hépatique, pédiatrique, grossesse et allaitement ; signaler tout usage hors indication.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-070 — Moyenne — LOT 245 · SSP O7.23

Emplacement : LOT_245_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.3 › fenêtre « poumons, pancréas, voies aériennes supérieures », 7.2 pancréas, 7.4 diabète lié à la mucoviscidose, 7.5 syndrome osseux

Contexte : Le cours renvoie aux standards ESPEN-ESPGHAN-ECFS 2024 sans en avoir lu le texte : seuils glycémiques du CFRD, dépistage, densité osseuse et fertilité absents.

Question : Quels critères de dépistage et de diagnostic du diabète lié à la mucoviscidose (HGPO annuelle dès 10 ans, seuils), quel traitement (insuline), quel dépistage osseux (DXA : âge, fréquence) et quelles recommandations sur la fertilité et les voies aériennes supérieures donnent les standards ECFS 2023–2024 et ISPAD 2022 ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-083 — Haute — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html ; LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 2 › fenêtre « Droit d'aviser l'APEA » ; Partie 4 › fenêtre T8.3 ; Bloc 1 › II. cadre juridique et II.D. droit et obligation d'aviser (fenêtre transversale II.6) ; Partie 3 › fenêtres 6.7, 7.2, 7.4 et 7.6 (droit d'aviser, poursuite d'office, documentation)

Contexte : Le cours décrit trois niveaux de droit et cite CC 314c, 314d, 443, 453, CP 321 ; obligations cantonales d'aviser (deux exemples non exhaustifs), modalités cantonales de dénonciation et conservation du dossier non trouvées.

Question : Quelles obligations et quels droits d'aviser l'APEA ou de dénoncer à la police s'imposent au médecin en Suisse (CC 314c–314e, 443, 453 ; CP 321, 364 ; lois cantonales de santé, exemple de Vaud, Genève, Neuchâtel, Berne, Zurich) en cas de mise en danger d'un enfant, d'un adulte vulnérable ou de maltraitance d'une personne âgée ? Quelles règles de conservation et d'accès au dossier et aux photographies s'appliquent (durée cantonale, LPD) ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-085 — Haute — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Bloc 1 › moyens pharmacologiques (lithium, Quilonorm® retard) ; Partie 2 › DX.3 › épidémiologie du suicide, 7.4 demande d'assistance au suicide, fenêtre transversale « Assistance au suicide »

Contexte : Le cours cite 958 suicides non assistés en 2022 (11,0/100 000) ; nombre de suicides assistés non retenu ; directives ASSM sur l'assistance au suicide non détaillées ; lithium sans indication antisuicidaire en Suisse.

Question : Quel est le nombre de suicides assistés et non assistés en Suisse selon l'OFS (dernière année publiée) ? Quelles directives ASSM « Attitude face à la fin de vie et à la mort » (2018, révisée 2021–2022) et quelle jurisprudence (ATF 133 I 58) encadrent l'évaluation de la capacité de discernement avant une assistance au suicide ? Quelle place donnent les recommandations suisses (SSPP) ou européennes au lithium dans la prévention du suicide, selon la FI suisse de Quilonorm® ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-086 — Haute — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 2 › DX.3 › fenêtre transversale « PAFA médical : procédure » ; Partie 4 › DX.9 › fenêtre T9.4 « placement à des fins d'assistance »

Contexte : Le cours cite les trois conditions du PAFA (CC 426) ; médecins habilités, durée du placement médical et voies de recours selon les cantons non détaillés.

Question : Quelles règles cantonales désignent les médecins habilités à ordonner un PAFA (CC 429) et fixent sa durée maximale (6 semaines au plus), et quelles procédures (recours CC 439, entretien, plan de traitement, mesures limitant la liberté CC 438) s'appliquent ? Que disent les directives ASSM sur les mesures de contrainte (2015, révision) ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-087 — Haute — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.4 › violence domestique (épidémiologie, fenêtre transversale « Secret médical et victimes »)

Contexte : Le cours cite 265 victimes d'homicide dans le couple de 2019 à 2023 et la procédure en quatre étapes sur le secret médical.

Question : Quels chiffres de la statistique policière OFS 2025 décrivent la violence domestique en Suisse, et quelles recommandations suisses guident le médecin (BFEG, guides cantonaux, LAVI : centres de consultation, constat médico-légal, levée du secret CP 321 ch. 2, Convention d'Istanbul) ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-089 — Haute — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › Partie 2 › DX.5 › maltraitance de l'enfant (épidémiologie, co-ingestions, traitement, surveillance biologique)

Contexte : Le cours cite 2380 enfants traités en 2025 par 19 cliniques pédiatriques ; aucune pharmacothérapie spécifique ; bilan de coagulation devant un hématome sans détail.

Question : Quel bilan recommandent Pédiatrie Suisse et le Groupe suisse de protection de l'enfant (Kinderschutz Schweiz / Fondation Protection de l'enfance) devant une suspicion de maltraitance ou de bébé secoué : bilan de coagulation, bilan squelettique, fond d'œil, imagerie cérébrale, examen de la fratrie ? Quelle conduite pour une intoxication suspecte de l'enfant (Tox Info Suisse) ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-093 — Haute — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Bloc 1 › outil pour DX.9 précarité ; Partie 4 › DX.9 › premier recours, fenêtres T9.1 (aide sociale), T9.2 (liste cantonale des mauvais payeurs), T9.5 (secret médical et sans-papiers), suivi ambulatoire

Contexte : Le cours dit qu'aucun outil validé n'a été retrouvé ; modalités de l'aide sociale cantonale, cantons ayant une liste de mauvais payeurs (LAMal art. 64a al. 7) et levée de la suspension, obligations cantonales d'annoncer et intervalles de suivi absents.

Question : Quels cantons tiennent en 2026 une liste des assurés en retard de paiement (LAMal art. 64a al. 7, révision entrée en vigueur en 2024 : interdiction pour les mineurs), comment se lève la suspension et que couvre l'urgence ? Quels droits d'accès aux soins ont les sans-papiers (affiliation LAMal, réduction de primes, Cst. 12) et existe-t-il un outil validé de repérage de la précarité en Suisse (DiPCare-Q, Genève) ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-096 — Haute — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.8 › 7.3 mutilations génitales féminines (douleurs, complications obstétricales)

Contexte : Le cours oriente vers le Réseau suisse contre l'excision ; mécanismes et complications détaillées non trouvés.

Question : Quelles recommandations suisses (SSGO avis d'experts sur les MGF, Réseau suisse contre l'excision, OFSP) encadrent la prise en charge des femmes excisées : classification OMS, complications gynécologiques et obstétricales, désinfibulation, interdiction de la réinfibulation, CP 124 et droit d'aviser pour une fillette à risque ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-097 — Haute — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.10 › 7.5 maladie contagieuse (dépistage tuberculose en détention)

Contexte : Le cours dit que le protocole suisse de dépistage en détention n'a pas été trouvé ; il cite l'OEp art. 30.

Question : Quel protocole suisse de dépistage de la tuberculose et des infections transmissibles (VIH, VHB, VHC) à l'entrée en détention recommandent l'OFSP, la Ligue pulmonaire suisse (Manuel de la tuberculose, édition la plus récente) et le Centre suisse de compétences en matière d'exécution des sanctions pénales (CSCSP/SKJV) ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-098 — Haute — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.10 › fenêtres T10.1 (mesures de contrainte), T10.2 (grève de la faim), T10.3 (secret médical), T10.5 (constat de violences), T10.6 (recherche sur les détenus)

Contexte : Le cours cite les directives ASSM sur l'exercice de la médecine auprès des personnes détenues (2013, mises à jour 2015) ; textes intégraux des mesures de contrainte, du Protocole d'Istanbul et des conditions de recherche (LRH) non lus.

Question : Que prévoient les directives ASSM en vigueur « Exercice de la médecine auprès de personnes détenues » (version, URL) sur la grève de la faim, les mesures de contrainte, le secret médical et la levée du secret, et quelle est la version la plus récente du Protocole d'Istanbul (2022) pour le constat de violences ? Quelles conditions la LRH (art. 28–31) impose-t-elle à la recherche sur des personnes détenues ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-091 — Moyenne — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.6 › adolescent (épidémiologie CP 187, 7.3 trouble alimentaire, suivi de la suicidalité, placement CC 314b)

Contexte : Le cours cite 1118 infractions CP 187 en 2025 ; critères du trouble alimentaire, fréquence du suivi de la suicidalité et règles du placement d'un mineur en milieu fermé non détaillés.

Question : Quels critères d'hospitalisation de l'adolescent souffrant d'anorexie mentale (fréquence cardiaque, IMC, kaliémie, phosphate) recommandent les sociétés suisses (SSPPEA, Pédiatrie Suisse) ou européennes ? Quel suivi de la suicidalité chez l'adolescent recommandent-elles, et quelles règles s'appliquent au placement d'un mineur en établissement fermé ou psychiatrique (CC 314b) ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-092 — Moyenne — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_246_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html › Partie 1 › DX.1 › fragilité (prévalence, populations particulières, lorazépam Temesta® et supplémentation, surveillance, pronostic)

Contexte : Le cours cite le phénotype de Fried et la CFS, la réduction de 50 % de la dose de Temesta® chez l'âgé ; prévalence suisse de la fragilité, spécialité suisse de supplémentation protéino-énergétique, adaptation à DFGe < 30 et calendrier de surveillance absents.

Question : Quelle prévalence suisse de la fragilité (cohortes Lc65+, SHARE Suisse, OFS) existe ? Quelles recommandations suisses (SSGG, Ligue suisse contre le rhumatisme, guidelines de prévention des chutes « StoppSturz ») ou européennes (ICFSR 2017, World Falls Guidelines 2022) fixent la prise en charge : exercice, supplémentation protéino-énergétique (produits suisses, apports cibles), vitamine D (dose), déprescription des benzodiazépines, calendrier de réévaluation ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-094 — Moyenne — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › Partie 3 › DX.7 › maltraitance de la personne âgée (épidémiologie BFEG, 7.5 contention abusive, traitement des lésions, surveillance biologique)

Contexte : Le cours cite 300 000 à 500 000 personnes de 60 ans et plus victimes chaque année (BFEG), méthode non détaillée ; complications de la contention et suivi de la dénutrition non sourcés.

Question : Quelle est la méthode et la source exacte de l'estimation suisse de 300 000 à 500 000 victimes (BFEG, rapport du Conseil fédéral 2020 « Prévenir la violence sur les personnes âgées », URL) ? Quelles complications de la contention physique et quelles règles légales (CC 383–385) et recommandations (ASSM mesures de contrainte, Curaviva) s'appliquent ? Quel suivi de la dénutrition recommandent les sociétés suisses (SSNC/GESKES) ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-095 — Moyenne — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.8 › fenêtres T8.1 « interprétariat » et Bio-Mathématique 8.1 (trois pays principaux), conditions de l'interprète auxiliaire

Contexte : Le cours dit que la liste des langues des demandeurs d'asile, la méthode de repérage de la langue et la qualité d'« auxiliaire » de l'interprète au sens du CP 321 ne figurent pas dans les

sources.

Question : Quelles sont les principales nationalités et langues des demandeurs d'asile en Suisse (SEM, statistique 2025) ; quelles recommandations de l'OFSP et d'INTERPRET encadrent l'interprétariat communautaire (repérage de la langue, financement, secret) ; l'interprète est-il un auxiliaire soumis au CP 321 ? Citer le texte suisse en vigueur (RS, article, alinéa, état du texte, URL) et, s'il y a lieu, les directives ASSM ou le Code de déontologie FMH applicables, avec leur année.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

E-099 — Moyenne — LOT 246 · SSP O7.24

Emplacement : LOT_246_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › Partie 4 › DX.10 › troubles mentaux en détention et suivi psychiatrique sous TAO

Contexte : Le cours cite un excès de troubles mentaux en prison et un suivi sous TAO avec ECG selon les facteurs de risque ; fréquence des consultations psychiatriques absente.

Question : Quelles recommandations suisses (SSAM « Recommandations médicales pour le traitement par agonistes opioïdes » 2020 ou plus récentes, CSCSP, OFSP) encadrent le TAO et le suivi psychiatrique en détention : poursuite du traitement à l'entrée, ECG sous méthadone, prévention de l'overdose à la sortie (naloxone) ? Citer la recommandation suisse en vigueur (société savante ou autorité, titre, année, URL) ; comparer sa version la plus récente avec celle citée dans le cours et lister les différences ; à défaut de source suisse, donner la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P23 — 19 questions : E-064, E-065, E-066, E-068, E-070, E-083, E-085, E-086, E-087, E-089, E-093, E-096, E-097, E-098, E-091, E-092, E-094, E-095, E-099